

TEMA 6.13 • INFECTOLOGÍA

Enfermedades de Transmisión Sexual – Segunda Parte

PERFIL EUNACOM 1.05.1.013
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

ETS Parte II — Chancroide y Sífilis

Chancroide (Shancroblando)

- **Agente:** *Haemophilus ducreyi*.
 - **Clínica:** Úlcera genital **única, dolorosa**, de aspecto sucio/purulento. Adenopatías inguinales que se abscedan y fistulízan (muy característico).
 - **Diagnóstico:** Clínico.
 - **Tratamiento:** Ceftriaxona dosis única o **Azitromicina × 5 días**.
- > Diferencia clave: Chancro sífilítico = indoloro / Chancroide = **doloroso**.

Sífilis

- **Agente:** *Treponema pallidum* (espiroqueta).

Estadios Clínicos

TABLA 6.13.1: ESTADIO VS CLÍNICA CARACTERÍSTICA	
ESTADIO	CLÍNICA CARACTERÍSTICA
Primaria	Chancro sífilítico: úlcera única, indurada, indolora , de aspecto limpio. En genitales.
Secundaria	Fiebre + exantema eritematoso descamativo generalizado con afectación de palmas y plantas (muy específico).
Terciaria	Gomas sífilíticas, Tabes dorsal (pérdida sensibilidad EEII), Aneurisma aórtico, Neurosífilis (demencia).
Latente	Asintomática. Solo detectable por exámenes.

Diagnóstico Serológico

TABLA 6.13.2: PRUEBA VS TIPO		
PRUEBA	TIPO	USO
VDRL / RPR	No treponémica (inespecífica)	Screening + seguimiento de respuesta al tratamiento (se negativiza)
FTA-ABS / MHATP	Treponémica (específica)	Confirmación (permanece positiva de por vida)

TABLA 6.13.3: VDRL/RPR VS FTA-ABS		
VDRL/RPR	FTA-ABS	INTERPRETACIÓN
(+)	(-)	Falso positivo del screening
(-)	(+)	Sífilis curada (FTA permanece +)
(+)	(+)	Sífilis activa

> Sífilis primaria: ambas pruebas pueden estar negativas → Diagnóstico **clínico** + microscopía de campo oscuro.

Tratamiento

TABLA 6.13.4: ESTADIO VS TRATAMIENTO	
ESTADIO	TRATAMIENTO
Primaria / Secundaria	Penicilina Benzatínica 2.400.000 UI IM × 1-2 dosis
Terciaria	Penicilina Benzatínica × 3 dosis semanales
Neurosífilis	Penicilina G EV (no benzatínica)
Alérgico a PNC	Azitromicina, Claritromicina o Doxiciclina (o Ceftriaxona si no hay alergia severa)

EUNACOM CRITERIOS

Tratar sin esperar FTA si: Embarazada (riesgo TORCH) + VDRL (+) / Clínica de sífilis secundaria / Paciente con sífilis previa (FTA siempre positiva, no sirve para confirmar nueva infección).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de 35 años consulta por úlcera genital única, indolora, de bordes regulares y aspecto limpio, de 10 días de evolución. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el examen de apoyo más adecuado?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Enfermedades de Transmisión Sexual - Segunda Parte. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Chancroide (H. ducreyi): úlcera única **DOLOROSA**, aspecto sucio, adenopatías inguinales que se absceden y fistulizan. Tratamiento: ceftriaxona o azitromicina.
- Sífilis primaria (chancro): úlcera única, indurada, **INDOLORA**, aspecto limpio. Diagnóstico clínico, apoyado por microscopía de campo oscuro.
- Sífilis secundaria: exantema que afecta **PALMAS Y PLANTAS** (muy sugerente). Sífilis terciaria: gomas, tabes dorsal, aneurisma aórtico, neurosífilis.
- Pruebas no treponémicas (RPR, VDRL): screening, negativizan con tratamiento (seguimiento). Treponémicas (FTA-ABS, MHA-TP): confirmación, positivas de por vida.
- Tratamiento: penicilina benzatina 2,4 millones IM. Primaria/secundaria: 1-2 dosis. Terciaria: 3 dosis semanales. Neurosífilis: penicilina G EV.
- Tratar de inmediato sin esperar confirmación: embarazada con VDRL+, clínica de sífilis secundaria, antecedente de sífilis previa.
- Ladillas (Pthirus pubis): permetrina 1% esquema 1-6-1. Siempre descartar otras ETS concomitantes.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL - SEGUNDA PARTE)**PREGUNTA 1**

Hombre de 35 años consulta por úlcera genital única, indolora, de bordes regulares y aspecto limpio, de 10 días de evolución. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el examen de apoyo más adecuado?

- A)** Chancroide; cultivo para *Haemophilus ducreyi*
- B)** Sífilis primaria; VDRL y FTA-ABS
- C)** Sífilis primaria; microscopía de campo oscuro
- D)** Herpes genital; PCR para VHS
- E)** Condiloma acuminado; biopsia de la lesión

PREGUNTA 2

Mujer embarazada de 12 semanas se realiza exámenes de rutina. El VDRL sale positivo en títulos 1:8. No tiene síntomas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Esperar resultado del FTA-ABS antes de iniciar tratamiento
- B)** Tratar de inmediato con penicilina benzatina y solicitar FTA-ABS
- C)** Repetir VDRL en 4 semanas para confirmar
- D)** Considerar falso positivo ya que el embarazo es la primera causa
- E)** Solicitar microscopía de campo oscuro para confirmar

PREGUNTA 3

Paciente con antecedente de sífilis tratada hace 3 años consulta por VDRL positivo 1:4 encontrado en control de rutina. FTA-ABS positivo. ¿Cómo interpreta estos resultados?

- A)** Falso positivo del VDRL, paciente sano
- B)** Sífilis activa, requiere tratamiento
- C)** Sífilis curada, el FTA-ABS permanece positivo de por vida
- D)** Posible reinfección, tratar con penicilina benzatina sin esperar más exámenes
- E)** Solicitar microscopía de campo oscuro para confirmar reinfección

RESUMEN: ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL - SEGUNDA PARTE

Esta clase continúa con las ETS, abordando chancroide, sífilis y otras infecciones. El chancroide (chancro blando) es causado por *Haemophilus ducreyi* y se presenta como una úlcera única dolorosa de aspecto sucio/purulento con adenopatías inguinales que se absceden y fistulizan. Se trata con ceftriaxona o macrólidos (azitromicina 5 días). La sífilis (*Treponema pallidum*) tiene cuatro presentaciones: primaria (chancro: úlcera única indurada, indolora, aspecto limpio), secundaria (exantema con placas eritematosas que afectan palmas y plantas), terciaria (gomos sífilíticas, tabes dorsal, aneurisma aórtico, neurosífilis) y latente (asintomática). El diagnóstico usa pruebas no treponémicas de screening (RPR, VDRL) y treponémicas confirmatorias (FTA-ABS, MHA-TP). El VDRL/RPR negativizan con tratamiento y sirven para seguimiento; el FTA-ABS permanece positivo de por vida. El tratamiento es penicilina benzatina 2,4 millones IM: una a dos dosis para primaria/secundaria, tres dosis semanales para terciaria, y penicilina G endovenosa para neurosífilis. Se trata de inmediato sin esperar confirmación en: embarazo, clínica de sífilis secundaria, y antecedente de sífilis previa. La sífilis primaria se diagnostica clínicamente y puede apoyarse con microscopía de campo oscuro. Otras ETS mencionadas: ladillas (*Phthirus pubis*) tratadas con permetrina al 1% en esquema 1-6-1, donovanosis, y la importancia de descartar siempre otras ETS concomitantes.